

GUÍA BABY MATHEW IA

El sueño de tu bebé: la rutina, tu mejor opción

Cómo evoluciona el sueño durante el primer año, mes a mes, y cómo construir una rutina que funcione para tu familia.

Bienvenida

Si llegaste a esta guía, probablemente estás contando horas de sueño en lugar de ovejas. Es de las preguntas más frecuentes de la crianza temprana: ¿cuánto debería dormir mi bebé?, ¿por qué se despierta tanto?, ¿cuándo empieza a dormir "toda la noche"? La respuesta corta es que no hay un interruptor único — el sueño del bebé evoluciona por etapas, y lo que es normal a las 6 semanas no lo es a los 6 meses.

Esta guía resume, mes a mes, qué esperar del sueño de tu bebé durante el primer año, cómo construir una rutina que lo acompañe (sin que se vuelva una obsesión) y qué recomendaciones de sueño seguro son innegociables. Está basada en las guías de sueño seguro de la Academia Americana de Pediatría (AAP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero no reemplaza el criterio de tu pediatra.

> **Cómo usar esta guía:** lee primero el capítulo de "sueño seguro" (página 7) — son las reglas que no cambian sin importar la edad. Luego ve directo a la etapa de tu bebé y vuelve a esta guía cada vez que cambie de etapa.

Contenido

01 Por qué una rutina de sueño sí hace la diferencia — pág. 3

02 0-3 meses: el ajuste inicial — pág. 3

03 4-6 meses: empieza el patrón — pág. 4

04 7-9 meses: consolidando la noche — pág. 5

05 10-12 meses: regresiones y constancia — pág. 6

06 Sueño seguro — lo que no es negociable — pág. 7

07 Señales de alarma — cuándo consultar — pág. 7

08 Checklist de la rutina nocturna — pág. 8

Por qué una rutina de sueño hace la diferencia

Un bebé no nace sabiendo diferenciar el día de la noche — ese reloj interno (ritmo circadiano) se desarrolla con el tiempo. Una rutina predecible (los mismos pasos, en el mismo orden, a una hora similar) le da a tu bebé señales claras de que se acerca el sueño, y esas señales aceleran la maduración de ese reloj interno. No se trata de rigidez militar; se trata de repetición.

> **Vale la pena saber:** la rutina beneficia tanto al bebé como a los cuidadores — una rutina no cambia la genética del sueño de tu bebé, pero sí reduce el tiempo que tarda en dormirse y los despertares nocturnos a medida que crece.

MESES 0 – 3

0–3 meses: el ajuste inicial

Qué es esperable

- Duerme entre 14 y 17 horas al día, repartidas en bloques cortos de 2-4 horas, de día y de noche por igual.
- No hay todavía un ritmo circadiano establecido — es normal que confunda el día con la noche.
- Se despierta a comer con frecuencia (cada 2-3 horas aprox.), y eso es necesario para su crecimiento, no un mal hábito que corregir.

Qué priorizar

- Exponerlo a luz natural durante el día y mantener el ambiente oscuro y tranquilo de noche, para ayudar a su reloj interno a diferenciarlos.
- Empezar una secuencia simple antes de dormir (baño o cambio de pañal, luz baja, canción o arrullo) — no importa cuál, importa que se repita.
- Aprovechar las "ventanas de sueño": señales de cansancio (bostezos, frotarse los ojos, irritabilidad) antes de que llegue el llanto por sobrecansancio.

MESES 4 – 6

4-6 meses: empieza el patrón

Qué es esperable

- El ritmo circadiano empieza a consolidarse — muchos bebés comienzan a distinguir mejor el día de la noche.
- Duerme entre 12 y 16 horas al día; las siestas empiezan a volverse más predecibles (usualmente 3 siestas).
- Algunos bebés logran bloques de sueño nocturno más largos (5-6 horas seguidas), aunque despertarse 1-2 veces sigue siendo normal.
- Alrededor de los 4 meses puede aparecer la llamada "regresión del sueño de los 4 meses" — un cambio real y permanente en la arquitectura del sueño (no una fase que "se cura sola" en días), que suele coincidir con más despertares.

Qué priorizar

- Fijar una hora aproximada de inicio de la rutina nocturna y mantenerla, incluso si el horario de siestas varía.
- Empezar a introducir el "ambiente de sueño seguro" de forma consistente en todas las siestas y la noche (ver capítulo 6).
- Si el pediatra ya dio luz verde a la alimentación complementaria, ten presente que el hambre nocturna puede fluctuar durante la transición.

> **Vale la pena saber:** esta etapa es donde muchas familias deciden si acompañan el sueño de forma más activa o buscan que el bebé se duerma con menos ayuda — ambas son válidas; lo importante es la consistencia de lo que elijas, no cuál elijas.

MESES 7 – 9

7-9 meses: consolidando la noche

Qué es esperable

- Duerme entre 12 y 15 horas al día; la mayoría pasa a 2 siestas (mañana y tarde).
- Muchos bebés ya son capaces de dormir tramos nocturnos largos sin necesidad de comer, aunque algunos siguen despertándose por hábito o por hambre real — ambas razones son válidas y conviene distinguirlas con calma.
- Aparece con frecuencia la ansiedad de separación: el bebé llora al notar que el cuidador se aleja, incluido a la hora de dormir.
- El gateo, los dientes o nuevos hitos motores pueden interrumpir temporalmente un sueño que ya estaba estable.

Qué priorizar

- Mantener la misma secuencia de rutina incluso en los días "difíciles" — la ansiedad de separación mejora con previsibilidad, no con cambios de estrategia.
- Un objeto de transición seguro (ver recomendaciones de seguridad en el capítulo 6) puede ayudar, siempre dentro de las pautas de sueño seguro para su edad.
- Si decides ajustar el método de acompañamiento nocturno, dale al menos 1-2 semanas de consistencia antes de evaluar si funciona.

MESES 10 – 12

10-12 meses: regresiones y constancia

Qué es esperable

- Duerme entre 11 y 14 horas al día, usualmente con 1-2 siestas (la transición a una sola siesta suele ocurrir entre los 12 y 18 meses).
- Es común otra regresión de sueño cerca de los 9-10 meses, ligada a hitos como gatear, pararse o dar los primeros pasos — el cerebro está muy activo y eso afecta las noches.
- Ponerse de pie en la cuna y no saber todavía cómo volver a acostarse puede generar despertares que no son hambre ni malestar, sino frustración motora.

Qué priorizar

- Practicar la habilidad de pararse/sentarse durante el día para que de noche sea menos probable que se quede "atascado" de pie.
- Sostener la rutina y el horario incluso durante las regresiones — son temporales, generalmente semanas, no meses.
- Revisar que la cuna siga cumpliendo las pautas de sueño seguro a medida que el bebé se mueve más (ver capítulo 6).

> **Vale la pena saber:** una regresión de sueño no borra el progreso anterior — es una etapa pasajera dentro de una curva que, en general, sigue mejorando durante el segundo año.

Resumen de horas de sueño por edad

Edad	Sueño total/día	Siestas típicas
0-3 meses	14-17 horas	Sin patrón fijo
4-6 meses	12-16 horas	3 siestas
7-9 meses	12-15 horas	2 siestas
10-12 meses	11-14 horas	1-2 siestas

Rangos de referencia general (AAP). Cada bebé tiene variación individual normal — consulta a tu pediatra si tienes dudas sobre el caso particular de tu hijo o hija.

Sueño seguro y señales de alarma

Sueño seguro — lo que no es negociable (AAP / OMS)

- Siempre boca arriba para dormir, de noche y en siestas, hasta que el bebé pueda girarse solo de forma consistente en ambas direcciones.
- Superficie firme y plana (cuna o moisés certificado) — nunca en sofás, camas de adultos, sillas de auto fuera del carro, o superficies blandas.
- Cuna "despejada": sin almohadas, cojines, edredones, protectores de cuna acolchados, peluches ni objetos sueltos dentro.
- Compartir habitación (no cama) con el bebé durante al menos los primeros 6 meses, idealmente hasta el año, reduce el riesgo de muerte súbita del lactante.
- Evitar el sobrecalentamiento: vestirlo con una capa similar a la que usarías tú, sin exceso de mantas.
- Evitar el humo de cigarrillo en el entorno del bebé, antes y después del nacimiento.
- La lactancia materna y el uso de chupete durante el sueño (una vez establecida la lactancia, si aplica) se asocian a menor riesgo de muerte súbita del lactante.

⚠ Señales de alarma — consulta a tu pediatra

- Pausas respiratorias visibles, ronquido fuerte y constante, o dificultad para respirar durante el sueño
- Somnolencia excesiva durante el día que no corresponde a su edad, o que te preocupa
- Fiebre, llanto inconsolable o rechazo del alimento que coincide con el problema de sueño
- Ausencia total de patrón de sueño/vigilia más allá de los 4-5 meses, o retroceso marcado en hitos de desarrollo junto con el problema de sueño

Una mala noche aislada no es motivo de alarma; un patrón sostenido de dificultad para dormir, junto con otros síntomas, sí merece revisión con tu pediatra.

Checklist de la rutina nocturna

No necesitas los 20 minutos de un spa — necesitas 15-20 minutos que se repitan igual cada noche. Elige 3 a 5 de estos pasos y mantenlos siempre en el mismo orden.

- [ ] Baño tibio o limpieza suave
- [ ] Pijama y, si aplica, cambio de pañal
- [ ] Luces bajas en toda la casa, no solo en el cuarto
- [ ] Alimentación (pecho, biberón o cena, según la edad), evitando que se duerma únicamente comiendo si buscas que aprenda a dormirse solo
- [ ] Canción, cuento corto o momento de calma repetido cada noche
- [ ] Despedida breve y consistente ("buenas noches, te quiero") antes de dejarlo en la cuna

Antes de empezar cualquier cambio de rutina

- [ ] Cuna verificada según las pautas de sueño seguro del capítulo 6
- [ ] Acuerdo entre los cuidadores sobre la secuencia y quién la hace
- [ ] Expectativa realista: toda rutina nueva toma 1-2 semanas de consistencia antes de notar el efecto



¿Y después de esta guía?

Cada bebé tiene su propio ritmo. Baby Mathew IA te acompaña semana a semana, resolviendo tus dudas en el momento en que las tienes — en gestación y durante los primeros dos años de tu bebé.

Sigue la conversación con Baby Mathew

Pregúntale lo que quieras, cuando quieras, gratis.

bebeteguia.com

Esta guía es material informativo general, elaborado con base en las recomendaciones de sueño seguro de la Academia Americana de Pediatría (AAP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). No sustituye la consulta, el diagnóstico ni el tratamiento de un profesional de la salud. Ante cualquier duda sobre el sueño o la salud de tu bebé, consulta siempre a tu pediatra.

© Baby Mathew IA — bebeteguia.com